

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL INSIGHT (SUMD)

Scale to Assess Unawareness of Mental Disorder — Evaluación Dimensional de la Conciencia de Enfermedad

Amador, Strauss, Yale, Flaum, Endicott & Gorman (1993) • Adaptación española validada

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Heteroaplicada mediante entrevista clínica. Valore el grado de conciencia (insight) y la atribución causal de cada síntoma puntuando del 1 (Conciencia completa) al 5 (Ausencia total de conciencia):

0 = No aplicable | 1 = Conciencia completa | 3 = Conciencia parcial/intermedia | 5 = Ausencia total de conciencia (anosognosia)

Nº	Dimensión del Insight / Atribución (SUMD)	0 NA	1 Total	2	3 Med	4	5 Nula
I. CONCIENCIA GENERAL DEL TRASTORNO Y TRATAMIENTO							
1	Conciencia general de padecer una enfermedad o trastorno mental						
2	Conciencia de los efectos y necesidad de la medicación psiquiátrica						
3	Conciencia de las consecuencias sociales y relacionales del trastorno						
II. CONCIENCIA Y ATRIBUCIÓN DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS							
4a	Conciencia de poseer alucinaciones (percepciones sensoriales irreales)						
4b	Atribución de las alucinaciones a un trastorno o enfermedad mental						
5a	Conciencia de poseer ideas delirantes o pensamientos inusuales						
5b	Atribución de los delirios a un trastorno o enfermedad mental						
6a	Conciencia de presentar desorganización del pensamiento o del habla						
6b	Atribución de la desorganización a un trastorno o enfermedad mental						
7a	Conciencia de embotamiento afectivo y pérdida de reactividad						
7b	Atribución del embotamiento a un trastorno o enfermedad mental						

PUNTUACIÓN Y RELEVANCIA TERAPÉUTICA (Amador et al., 1993)

Puntuación Global (Ítems 1 a 3):

- La media de los 3 primeros ítems constituye el índice de conciencia global de enfermedad.
- Puntuaciones de **4 a 5** definen anosognosia psiquiátrica severa.

Importancia en la Adherencia Terapéutica:

- El déficit de insight es el principal predictor independiente de abandono de la medicación antipsicótica y de recaídas hospitalarias en la esquizofrenia.